

Résistance de *Staphylococcus aureus* aux antibiotiques au CHU d’Annaba (Algérie) : bilan 2019-2025

Mots clés : *Staphylococcus aureus*, hémoculture, pédiatrie, résistance à la méticilline.

A.OTMANE, A.BOUHALA, C.BOUTARFA, I.FELFLI, I.BOUNAIDJA, M.BENHARKAT, K.HACHELFI,
H.BENCHERCHAR, A.BENALI, A.BOUARICHA, S.NEDJAI

Laboratoire central de microbiologie –Hôpital Dr Dorban- CHU d’Annaba

1. Introduction-objectif:

Staphylococcus aureus est un pathogène majeur chez l’homme, responsable de nombreuses infections à la fois communautaires et nosocomiales. La dissémination de souches multirésistantes aux antibiotiques et notamment résistantes à **la méticilline ou l’oxacilline (SARM)** complique la prise en charge des infections par *S.aureus* [1] .

Notre travail vise à déterminer le profil épidémiologique et la résistance aux antibiotiques des souches de *Staphylococcus aureus* isolées de prélèvements cliniques .

2. Matériels et méthodes :

Il s’agit d’une étude rétrospective de*Staphylococcus aureus* scriptive de **07 ans (2019-2025)** effectuée au laboratoire de microbiologie du **CHU d’Annaba** portant sur toutes les souches de isolées de prélèvements cliniques. Les souches dupliquées ainsi que celles provenant de porteurs asymptomatiques et d’environnement hospitalier ont été exclues.

L’identification des souches a fait appel aux méthodes conventionnelles et automatisées. La réalisation et l’interprétation des résultats de l’antibiogramme ont été faites selon les recommandations du CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) M100-36th Edition-2026.

3. Résultats :

Un total de 2193 souches cliniques non répétitives de *Staphylococcus aureus* a été isolé pendant la période d’étude.

Répartition selon les prélèvements (n=2193)

Prélèvement	Effectif (%)
Suppurations	1420 (64.75)
Hémoculture	465 (21.20)
Respiratoires basses	99 (04.51)
Autres	96 (04.38)
ORL	60 (02.73)
Articulaire	42 (01.91)
LCR	11 (00.50)

Répartition selon les services (n=2193)

Service	Effectif (%)
Maladies infectieuses	387 (17.65)
Pédiatrie	277 (12.63)
Grands brûlés	230 (10.49)
ORL	201 (09.16)
Endocrinologie	162 (07.39)
Réanimation pédiatrique	147 (06.70)
Réanimation adulte	119 (05.43)
Dermatologie	112 (05.11)
Médecine interne	109 (04.97)
Cardiologie	84 (03.83)

Taux de résistance aux antibiotiques

Antibiotique	Total (n=2193) Effectif (%)	Hémoculture (n=465) Effectif (%)
Oxacilline	1210 (55.17)	291 (62.58)
Gentamicine	381 (17.37)	122 (26.24)
Ciprofloxacine	743 (33.88)	185 (39.78)
Rifampicine	257 (11.72)	87 (18.71)
Cotrimoxazole	350 (15.96)	88 (18.92)
Acide fusidique	862 (39.31)	206 (44.30)
Erythromycine	693 (31.60)	159 (34.19)
Clindamycine	367 (16.73)	112 (24.09)
Pristinamycine	12 (00.55)	06 (01.29)
Tétracycline	661 (30.14)	133 (28.60)
Vancomycine	00 (00)	00 (00)

4. Discussion :

Les infections superficielles de la peau et des tissus mous et les hémocultures demeurent de loin les principaux sites d’isolement de *S.aureus* [2] . Les enfants sont largement exposés aux infections à *S.aureus* dans notre série.

La fréquence élevée des **SARM** de nos souche est inquiétante. Elle est nettement plus importante que la moyenne nationale (rapport 2024) [3]. Elle est également supérieure à celle rapportée en Tunisie [4] , en Europe [5] et aux Etats-Unis [6] .

L’efficacité de la ciprofloxacine et de l’acide fusidique, deux antibiotiques largement utilisés en thérapeutique, est également compromise.

La pristinamycine garde tout son intérêt dans les infections cutanées.

L’utilisation des bêta lactamines pour le traitement empirique des infections et notamment des bactériémies à *S.aureus* dans notre hôpital doit faire l’objet d’une **documentation microbiologique** ; le risque d’échec thérapeutique étant important. Le recours d’emblée à la vancomycine pour le traitement des infections sévères à *S.aureus* est malheureusement inéluctable et accroît la pression de sélection sur les **glycopeptides** [2].

5. Conclusion :

Le taux élevé de SARM complique la prise en charge des infections à *S. aureus* dans notre hôpital et **exclut le recours aux bêtalatamcines** dans l’antibiothérapie empirique. L’efficacité des fluoroquinolones et de l’acide fusidique est également affectée. Le traitement initial des infections sévères à *S.aureus* et notamment des bactériémies exige **d’emblée le recours aux glycopepitdes** et augmente la pression de sélection sur ces molécules.

Références :

[1] Lakhundi S, Zhang K. 2018. Methicillin resistant Staphylococcus aureus: molecular characterization, evolution, and epidemiology. Clin Microbiol Rev. 2018; 31(10): 1-103.

[2] Tong SYC, Davis JS, Eichenberger E, Holland TL, Fowler VG, Jr. Staphylococcus aureus infections: epidemiology, pathophysiology, clinical manifestations, and management. Clin Microbiol Rev. 2015 ; 28(3) : 603-661.

[3] Réseau Algérien de Surveillance de la Résistance des Bactéries aux Antibiotiques (AARN). Surveillance de la résistance des bactéries aux antibiotiques 24ème Rapport d’évaluation Edition 2024.

[4] Mezghani Maalej S , Jdidi Trabelsi J et al . Antimicrobial Susceptibility and Molecular Epidemiology of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Tunisia: Results of a Multicenter Study. J Infect Dis Epidemiol 2019; 5(02): 1-12.

[5] European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrobial resistance in the EU/EEA (EARS-Net) - Annual Epidemiological Report 2024. Stockholm: ECDC; 2025.

[6] CDC. Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2019. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, CDC; 2019.